

TERAPIA DE RECAÍDA

Repetir la biopsia en cada recaída para descartar transformación de alto grado

Recaídas localizadas: radioterapia de campo involucrado

Recaída asintomática con baja carga tumoral: observación activa o monoterapia con rituximab

Pacientes con alta carga tumoral

Primera recaída

- Inmunoterapia ± mantenimiento con anti-CD20 ± ASCT (en pacientes POD-24)
- Rituximab-lenalidomida (R2)*
- Tafasitamab-R2*[†]
- Epcoritamab-R2*[†]

Selección del tratamiento según:

- Carga tumoral
- Comorbilidades, síntomas asociados
- Tratamientos previos, toxicidad
- Preferencias del paciente

Segunda recaída y posteriores

- R2*
- Mosunetuzumab en monoterapia
- Tafasitamab-R2*[†]
- Epcoritamab-R2*[†]
- Tafasitamab[†] y Epcoritamab[†] en monoterapia
- Zanubrutinib-obinutuzumab[†]
- Terapia CAR-T[§]
- Inmunoterapia no cruzada (en pacientes seleccionados)
- Rituximab en monoterapia
- TPH alogénico (en pacientes seleccionados)

*Si *naïve* a lenalidomida. [†]No financiado en España. [§]Financiación en España en cuarta línea en POD24

ASCT: trasplante autólogo de células madre; AlloSCT: trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos; CAR-T: terapia con células T con receptor quimérico de antígeno; POD24: progresión de la enfermedad en los primeros 24 meses (por sus siglas en inglés *progression of disease within 24 months*).

Nota: las opciones de tratamiento no están ordenadas según las preferencias de los autores.